Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques

À RETENIR

- Nodule thyroïdien rare chez l'enfant mais risque de malignité supérieur à l'adulte : **22–26 %**.
- Prévalence ↑ entre **15–19 ans**, prédominance féminine franche ; formes < **10–15 ans** (prépubères) plus agressives.
- Présentation agressive : multifocal, souvent bilatéral ; métastases ganglionnaires au diagnostic **> 50 %** ; métastases pulmonaires **25 %**.
- Mais très **iodosensibles** et bon pronostic (**2 %** de mortalité).
- **1/3** des enfants avec métastases pulmonaires : maladie persistante mais non évolutive après ^{131}I.
- Thyroïdectomie totale toujours recommandée ; chirurgie d'emblée si **Bethesda 3**.
- Activité : **1 à 1,5 mCi/kg** (activité adulte × coefficients EANM).

I. Épidémiologie

- Le nodule thyroïdien chez l'enfant est **rare** ; cependant le risque qu'il soit malin est **supérieur à celui de l'adulte** : **22–26 %**.
- Si la prévalence du cancer thyroïdien est faible chez l'enfant, elle augmente entre **15–19 ans**, avec une prédominance féminine franche.
- Les formes chez l'enfant **< 10–15 ans** (prépubère) semblent plus agressives.
- Le cancer thyroïdien pédiatrique, essentiellement **papillaire**, a une présentation, une évolution et un pronostic différents de ceux de l'adulte.

II. Présentation

- Souvent **multifocal**, voire bilatéral.
- Métastases ganglionnaires au diagnostic : **> 50 %**.
- Métastases pulmonaires dans **25 %** des cas.

III. Pronostic

Malgré cette présentation clinique agressive, ces cancers sont très **iodosensibles** et leur pronostic est bon (**2 %** de mortalité).

IV. Surveillance

Une surveillance **à long terme** est indispensable : environ **1/3** des enfants avec métastases pulmonaires évoluent vers une maladie **persistante mais non évolutive** après ^{131}I.

V. Prise en charge

1. **Évaluation et traitement des nodules thyroïdiens** : identiques à ceux des adultes, avec une exception : **chirurgie d'emblée si Bethesda 3** à la cytologie.
2. **Thyroïdectomie totale toujours recommandée**, du fait de l'incidence accrue des formes multifocales, bilatérales, et des résultats à long terme montrant une ↓ du risque de récidive après TT.
3. **Chirurgien expérimenté** : les complications de la chirurgie sont ↑ chez les enfants.
4. **Niveau de risque post-opératoire** : bas – intermédiaire – élevé (« ATA »), avec une proposition de PEC et un suivi structuré spécifiques pour les enfants.

5. **^{131}I** : indiqué pour le traitement de la maladie ganglionnaire et locorégionale persistante qui ne peut être réséquée, et des métastases connues ou suspectées.
6. **Décision de poursuite du traitement** après la 1re administration d'^{131}I : compte tenu de la cinétique d'activité prolongée particulière de l'^{131}I chez l'enfant, la décision doit être individualisée.
   - → La balance bénéfice/risque doit être discutée individuellement.

Activité

- **Activité** : **1 à 1,5 mCi/kg**.
- Elle est calculée par multiplication de l'activité recommandée chez l'adulte par les coefficients établis par l'**EANM**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Risque de malignité d'un nodule thyroïdien chez l'enfant ?	22–26 % (supérieur à l'adulte).
2. Fréquence des métastases ganglionnaires et pulmonaires au diagnostic ?	Ganglionnaires > 50 % ; pulmonaires 25 %.
3. Mortalité du CDT pédiatrique ?	2 % (cancers très iodosensibles).
4. Quelle exception dans la prise en charge des nodules chez l'enfant ?	Chirurgie d'emblée si Bethesda 3.
5. Pourquoi la thyroïdectomie totale est-elle toujours recommandée ?	Formes multifocales et bilatérales fréquentes ; ↓ du risque de récidive après TT.
6. Activité d'iode 131 chez l'enfant ?	1 à 1,5 mCi/kg (activité adulte × coefficients EANM).